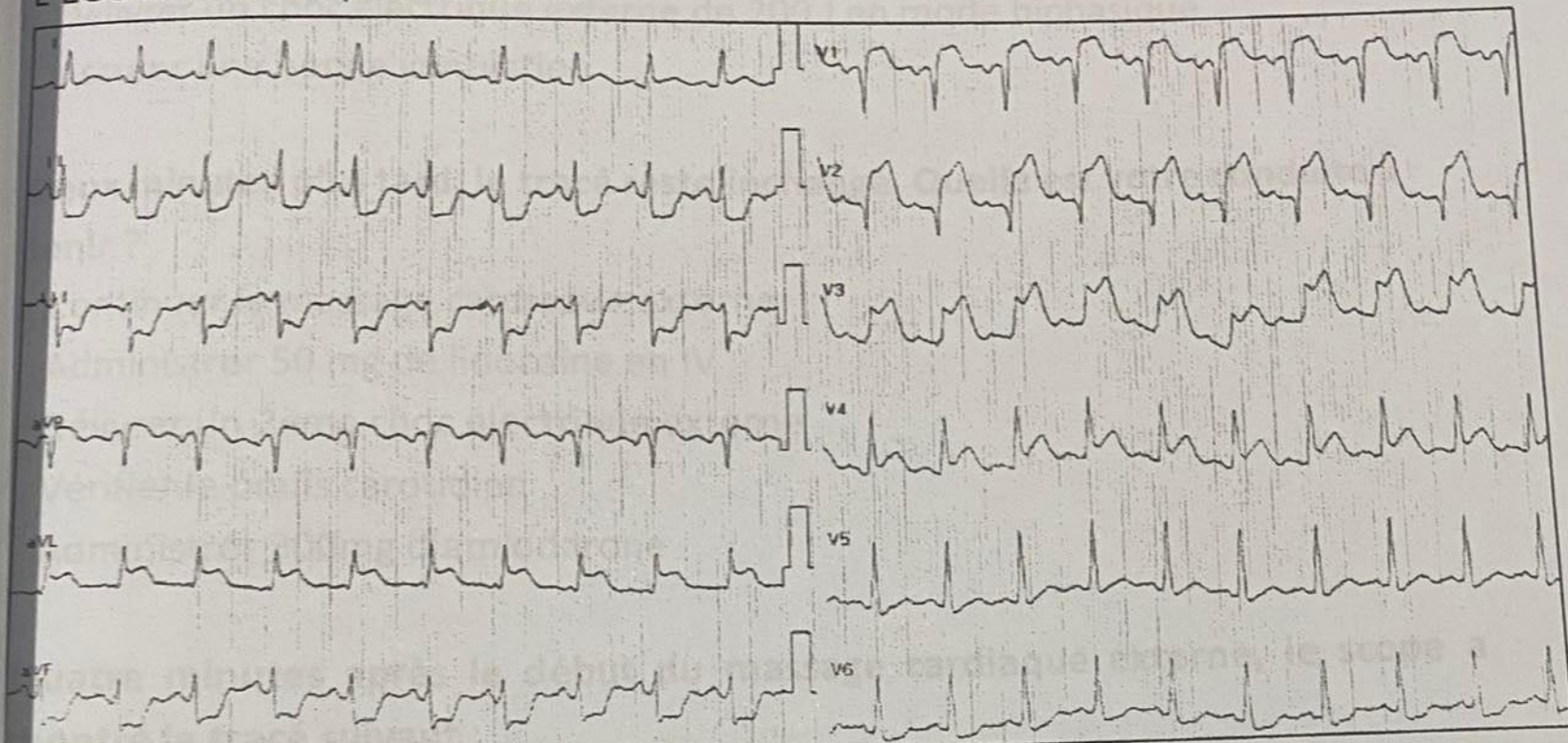


Un homme âgé de 70 ans, aux ATCD : tabagisme actif 40 PA, diabète type 2 et HTA sous IEC, a consulté à la salle d'urgence médicale pour une douleur thoracique rétro sternale de type brûlure irradiant vers la mâchoire. L'ECG montre l'aspect suivant :



A. Un syndrome coronarien ST+ en antéro-septo-apical

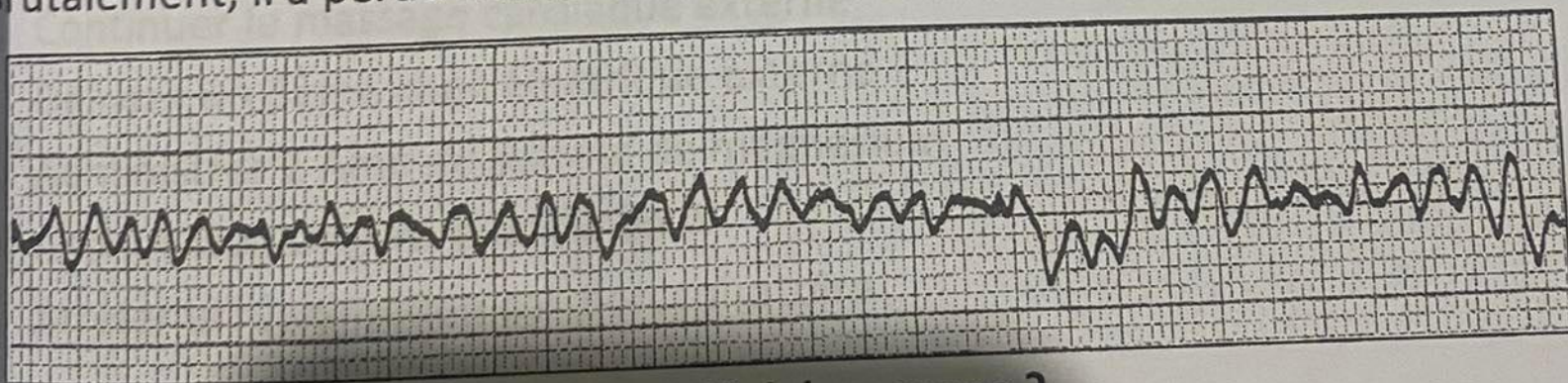
B. Un syndrome coronarien ST- en inferieur

C. Un bloc de branche gauche

D. Une tachycardie ventriculaire

E. Un bloc auriculo-ventriculaire de premier degré

Brutalement, il a perdu connaissance. Le scope a montré le tracé suivant :



2. Quel est le rythme électrique affiché au scope ?

A. Asystolie

B. Dissociation électromécanique

C. Fibrillation ventriculaire

D. Tachycardie ventriculaire

E. Torsade de pointe

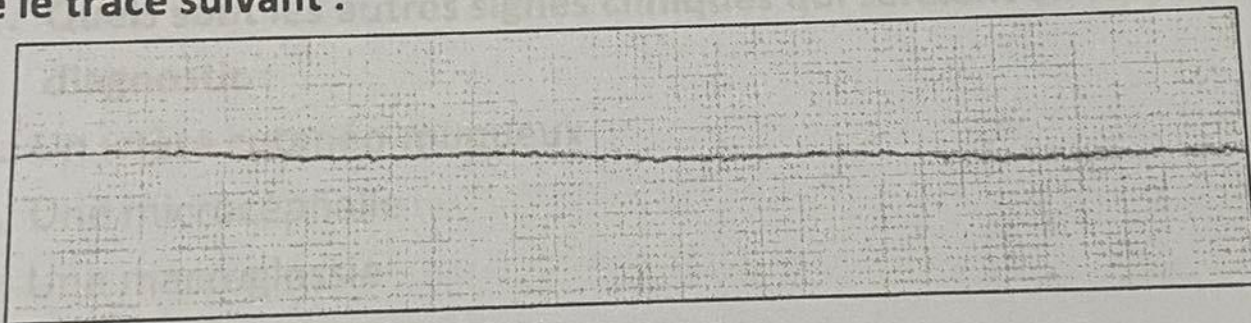
3. Quelle sera votre conduite à tenir en urgence?

- A. Commencer le massage cardiaque externe
- B. Administrer 150 mg d'amiodarone en IV
- C. Administrer 1mg adrénaline en IV
- D. Délivrer un choc électrique externe de 200 J en mode biphasique
- E. Assurer une bonne ventilation

4. Deux minutes plus tard, le tracé reste inchangé. Quelle est votre conduite à tenir ?

- A. Continuer le massage cardiaque externe
- B. Administrer 50 mg de lidocaïne en IV
- C. Délivrer un 2ème choc électrique externe
- D. Vérifier le pouls carotidien
- E. Administrer 300mg d'amiodarone

Quatre minutes après le début du massage cardiaque externe, le scope a montré le tracé suivant :



5. Quelle est votre conduite à tenir ?

- A. Continuer le massage cardiaque externe
- B. Délivrer un 3ème choc électrique externe
- C. Administrer 1 Amp de Sulfate de magnésium
- D. Administrer 1mg adrénaline en IV
- E. Arrêter la réanimation cardiorespiratoire

Cas clinique 2:

Un nourrisson âgé de 30 jours, issu d'une grossesse avec un accouchement à terme par voie basse, est admis pour hypotonie et hyporéactivité.

L'examen clinique:

- Poids : 3.9kg Taille: 48cm
- Facies infiltré
- Hypotonie axiale
- Hernie ombilicale

Une hypothyroïdie congénitale a été suspectée chez cet enfant

6. Parmi les signes cliniques suivants quels sont ceux à rechercher à l'anamnèse, chez ce nourrisson:

- A. Difficulté de téter avec des fausses routes
- B. Des vomissements post prandiaux
- C. Une consanguinité parentale
- D. Une constipation
- E. Une perte de poids

7. Quels sont les autres signes cliniques qui seraient en faveur de ce diagnostic :

- A. Un ictère cutanéomuqueux
- B. Une microcéphalie
- C. Une macroglossie
- D. Un micropenis
- E. Une chevelure abondante

8. Quels bilans demandez-vous pour confirmer votre diagnostic:

- A. FT4
- B. FT3
- C. Thyroglobuline
- D. TSH
- E. Anti corps Anti thyroïdien

9. La prise en charge comporte :

- A. Une hospitalisation
- B. L thyroxine 15 gamma/kg/j
- C. La recherche d'autres déficits antéhypophysaires
- D. La réalisation d'une échographie cervicale
- E. La réalisation en urgence d'une scintigraphie thyroïdienne

Cas clinique 3

Un homme âgé de 24 ans, diabétique sous insuline, est hospitalisé en urgence pour un coma dans un contexte d'apyrexie. L'examen neurologique ne trouve pas de raideur méningée ni de signes de localisation. L'ouverture des yeux est absente. La réponse verbale est absente. Il localise la douleur.

10. Quel examen à réaliser en urgence ?

- A. Calcémie
- B. Natrémie
- C. Glycémie au doigt
- D. Numération et formule sanguine
- E. Taux de prothrombine

11. Evaluer la profondeur du coma :

- A. Le score de Glasgow est à 5 /15(Y:1 V : 1 M :3)
- B. Le score de Glasgow est à 6 /15(Y:1 V : 1 M :4)
- C. Le score de Glasgow est à 7 /15(Y:1 V : 1 M :5)
- D. Le score de Glasgow est à 8 /15(Y:1 V : 1 M :6)
- E. Le score de Glasgow est à 9 /15(Y:3 V : 2 M :4)

12. Le scanner cérébral est sans anomalie, le bilan biologique est normal.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Accident vasculaire cérébral ischémique
- B. Etat de mal épileptique
- C. Coma d'origine toxique
- D. Méningite virale
- E. Hémorragie méningée

Cas clinique 4

Nourrisson de 9 mois consulte aux urgences pour une diarrhée aiguë faite de 4 selles liquides/j évoluant depuis 2 jours. L'examen montre un poids de 10Kg (La perte de poids est estimée à 4%) et une température à 38°C.

13. Afin d'évaluer son état d'hydratation, les signes cliniques à rechercher sont

- A. les cernes oculaires
- B. Les lésions cutanées purpuriques
- C. le pli cutané
- D. Le retard de développement psychomoteur
- E. L'allongement du temps de recoloration cutanée (TRC)

14. Votre conduite à tenir serait de

- A. Donner un soluté hydroélectrolytique à la salle d'urgence durant 4 heures
- B. Donner un soluté hydroélectrolytique avec retour à domicile
- C. Donner des antibiotiques
- D. Indiquer une réhydratation intraveineuse
- E. Arrêter le lait maternel

Deux jours après, les parents reconsultent aux urgences pour persistance de la symptomatologie avec augmentation de la fréquence de la diarrhée : 7 selles liquides par jour et des vomissements alimentaires à raison de 3 fois par jour.

A l'examen clinique, le nourrisson est plaintif avec des globes oculaires très enfoncés, muqueuse jugale très sèche, une fontanelle très déprimée, un pli cutané persistant.

Il pèse 8Kg900. Fréquence respiratoire à 28 c/mn. Fréquence cardiaque à 125 batt/mn, TRC : 4 secondes, TA : 90/50mmHg

15. Quel est votre diagnostic ?

- A. DSH sévère avec un score OMS à 8
- B. DSH sévère avec un score OMS à 14
- C. DSH modérée
- D. DSH sévère avec un score OMS à 10
- E. DSH sévère avec une perte pondérale de 5 à 10%

16. Quelle sera votre conduite à tenir immédiate

- A. Hospitalisation en USI
- B. Faire une PL en urgence
- C. Faire un ECBU en urgence
- D. Perfusion intraveineuse de SG 5% avec NaCl, KCL et gluconate de calcium.
- E. Administration de 550 cc du soluté de la perfusion IV durant les 4 premières heures

Le bilan biologique prélevé en urgence a montré à l'iono sanguin : Na^+ : 121 mmol/l K^+ : 4 mmol/l

17. Votre conduite à tenir est de

- A. Poursuivre la même perfusion et refaire un ionogramme sanguin dans 4 heures
- B. Corriger cette hyponatrémie par un apport de 14 ml de NaCl isotonique
- C. Administrer 14 ml de NaCl hypertonique à la seringue électrique en Y sur 4h
- D. Diminuer le débit de la perfusion afin d'assurer une réhydratation sur 48 h
- E. Refaire un ionogramme sanguin après 12h de la correction de l'hyponatrémie

Cas clinique 5

Patient âgé de 65 ans, instituteur retraité, porteur d'une ACFA sous Sintrom, tabagique, alcoolique, aux antécédents de radiothérapie pelvienne pour cancer du rectum 10 ans auparavant non récidivé. Il se plaint depuis 1 mois d'hématurie caillotante, avec troubles mictionnels irritatifs. L'examen physique est sans anomalies

L'ECBU montre une leucocyturie 1000/ml, hématurie 500 000/ml avec PSA : 2ng/ml, créatinémie : 78 $\mu\text{mol/l}$.

L'échographie urinaire a mis en évidence un épaississement circonférentiel irrégulier de la paroi vésicale ; hypertrophie prostatique avec un lobe médian saillant dans la lumière vésicale, les reins sont sans anomalies.

18. Les facteurs de risque de cancer de vessie chez ce patient sont :

- A. Profession
- B. Tabac
- C. Alcoolisme
- D. Radiothérapie pelvienne.
- E. ACFA

19. Le caractère urologique de cette hématurie peut être affirmé par :

- A. Sexe masculin
- B. Age
- C. Présence de caillots dans les urines
- D. Prise d'anti-coagulant
- E. Notion de tabagisme

20. Les causes possibles de l'hématurie chez ce patient sont :

- A. infection urinaire masculine.
- B. Radiothérapie pelvienne.
- C. Hypertrophie prostatique.
- D. Cancer de vessie.
- E. Prise de Sintrom

21. L'examen complémentaire que vous demandez en priorité est :

- A. Uroscanner
- B. Uro-IRM
- C. Cystoscopie
- D. Urétéro-pyélographie rétrograde
- E. Artériographie

Cas clinique 6

Une femme âgée de 52 ans sans antécédents consulte pour un diabète de type 2 de découverte récente sans amaigrissement.

A l'examen, Poids 69 kg, Taille à 1,71 m, Tour de taille 78 cm, TA = 160/90 mmHg vérifiée, L'examen somatique est normal

A la biologie : Glycémie à jeun 2,2 g/l, HbA1c 8,7%, Créatininémie 60 $\mu\text{mol/l}$, cholestérol : 2,6 g/l, Triglycérides : 2,1 g/l HDL cholestérol : 0,3 g/l, microalbuminurie : 240 mg/24h, ECBU négatif

22. Les facteurs de risque cardiovasculaire chez cette patiente en dehors du diabète sont :

- A. Age
- B. HTA
- C. Microalbuminurie
- D. HypoHDLémie
- E. Répartition androïde de la graisse

23. Les objectifs thérapeutiques chez cette patiente sont

- A. PA inférieure 130/80mmHg
- B. Microalbuminurie inférieure à 30mg/24h
- C. HbA1C à 7,5%
- D. Cholestérolémie inférieure à 2,1 g/l
- E. Glycémie post prandiale inférieure à 1,8g/l

24. Le traitement de cette patiente comporte :

- A. Un Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II
- B. Un Biguanide
- C. Un fibraté
- D. Un Inhibiteur de DPP4
- E. Insuline Rapide

25. Les mesures diététiques chez cette patiente comportent:

- A. Un régime hypocalorique
- B. Un apport de 300mg/j de cholestérol
- C. Un régime normo glucidique
- D. Un régime hypo protidique
- E. Eviter les acides gras trans

Cas clinique 7

Un cadre âgé de 62 ans, sans tares, est adressé en Urologie pour PSA à 5ng/ml, prescrit dans le cadre d'un bilan de routine, il est marié ayant une activité sexuelle régulière et normale. Le score IPSS est calculé à 1 et l'évaluation de la qualité de vie liée aux symptômes urinaires est égale à 0. Le toucher rectal montre une prostate de 30 cm³ homogène symétrique à surface lisse élastique indolore. Les biopsies prostatiques montrent un adénocarcinome prostatique présent sur une seule carotte sur les 12 prélevées avec une longueur tumorale de moins de 10% de la carotte envahie et un score de Gleason à 6 (3+3).

26. Chez ce patient, les biopsies prostatiques auraient pu se compliquer de:

- A. Rétention vésicale complète
- B. Hématurie
- C. Rectorragies
- D. Hémospermie
- E. Méléna

27. Le stade tumoral « T » chez ce patient selon la classification TNM est :

- A. T1a
- B. T1b
- C. T1c
- D. T2a
- E. T2b

28. Le groupe histo-pronostic de l'ISUP correspondant au score de Gleason chez ce patient est :

- A. Groupe 1
- B. Groupe 2
- C. Groupe 3
- D. Groupe 4
- E. Groupe 5

29. Selon la classification de D'amico, cet adénocarcinome est classé de :

- A. Faible risque
- B. Risque intermédiaire favorable
- C. Risque intermédiaire défavorable
- D. Haut risque
- E. Très haut risque

30. Le bilan d'extension chez ce patient comporte impérativement :

- A. Scanner abdomino-pelvien
- B. Radiographie du Thorax
- C. IRM pelvienne
- D. Scintigraphie osseuse
- E. Aucun bilan d'extension n'est nécessaire

31. Les modalités thérapeutiques qu'on peut proposer chez ce patient sont :

- A. Hormonothérapie
- B. Radio-hormonothérapie
- C. Radiothérapie seule
- D. Prostatectomie radicale
- E. Surveillance active

Cas clinique 8

Madame A.M âgée de 42 ans, hypertendue sous traitement, consulte pour des lombalgies droites fébriles. L'examen clinique trouve une fosse lombaire droite sensible, une fièvre à 40°, et des urines claires. A la biologie : Globules blancs : 22500 el/ml, hémoglobine : 13 g/dl, plaquettes : 250000 el/ml, CRP à 230 mg/l et créatininémie : 100 micromoles/l (12 mg/l). L'arbre urinaire sans préparation est sans anomalies. L'échographie rénale montre un foyer hypoéchogène rénal droit de 18 mm polaire inférieur. Un uroscanner a montré une lésion rénale droite polaire inférieure de 2 cm hypodense, se rehaussant de façon moindre que le parenchyme sain, décrite comme étant triangulaire à base externe et à sommet hilare. Il n'y a pas de dilatation des cavités rénales, sans lithiasse visible, le rein gauche est agénésique

32. Quel est votre diagnostic ?

- A. PNA droite simple
- B. PNA droite compliquée
- C. Cystite
- D. Colique néphrétique droite
- E. Anthrax du rein droit

33. Le mécanisme physiopathologique de cette atteinte rénale associe :

- A. Infection par voie hématogène
- B. Infection par voie canalaire rétrograde
- C. Infection par contiguité
- D. complication d'une infection locorégionale
- E. des micro thrombi inflammatoires ou infectieux expliquant l'atteinte rénale systématisée

34. La prise en charge thérapeutique immédiate comporte :

- A. ECBU
- B. Hémocultures
- C. Bi antibiothérapie parentérale
- D. recherche de la porte d'entrée
- E. Montée de sonde JJ droite

L'évolution a été marquée par la persistance au bout de 48 h d'une fièvre à 39° avec aggravation des lombalgies malgré votre prise en charge.

35. Quelle complication redoutez-vous ?

- A. Abscess du rein droit
- B. Rupture du fornix rénal droit
- C. Phlegmon périnéphrétique droit
- D. Pyonéphrose droite
- E. Pyocyste vésical

36. Quel examen réalisez-vous pour le confirmer ?

- A. Echographie rénale
- B. Scintigraphie rénale au DMSA
- C. Scanner abdomino- pelvien sans injection
- D. Scanner abdomino pelvien sans et avec injection de produit de contraste
- E. URO IRM

Cas clinique 9

Un patient âgé de 25 ans sans antécédent victime d'une chute du troisième étage (environ 10m). Il est transporté par la protection civile au service des urgences. L'examen initial trouve: Une fréquence respiratoire à 24 cycles/mn, une bonne ampliation thoracique. A l'auscultation pulmonaire les murmures vésiculaires sont bien perçus et symétriques. La saturation pulsée en oxygène est indétectable- La pression artérielle et à 60/30 mm Hg, une fréquence cardiaque à 130 battements/mn, une froideur des extrémités et des conjonctives pales.

Lorsqu'il ouvre les yeux à la stimulation douloureuse, il localise la douleur et il n'y a pas de réponse verbale. Son abdomen est ballonné. Une fracture ouverte de la jambe gauche a été constatée.

37. Les critères de gravité immédiate chez ce patient sont :

- A. La présence d'une pression artérielle systolique <65 mm Hg
- B. Une fréquence cardiaque à 130btt/min
- C. La chute du troisième étage (environ 10 m)
- D. La présence d'un abdomen ballonné
- E. Le coma

38. Le score de Glasgow est à :

- A. 12/15
- B. 9/15
- C. 8/15
- D. 6/15
- E. 3/15

39. La prise en charge hémodynamique immédiate de ce patient doit comporter :

- A. Un remplissage vasculaire par les cristalloïdes seuls
- B. L'administration de la dobutamine
- C. L'administration de la noradrénaline
- D. La mise en place de 2 voies veineuses périphériques
- E. Un monitoring continu de la pression artérielle par un cathéter artériel

40. Le bilan biologique obligatoire à l'arrivée du patient comporte

- A. Un groupe sanguin
- B. Une NFS
- C. Un bilan d'hémostase
- D. Urée - créatinine
- E. Un ionogramme sanguin

Le bilan lésionnel initial (radio thorax, radio bassin et échographie abdominale) a montré la présence d'un hémopéritoine de grande abondance en rapport avec une contusion de la rate.

1. Quelle est votre attitude thérapeutique ?

- A. compléter par un body scanner
- B. Admission en réanimation pour stabilisation de son état hémodynamique.
- C. Splénectomie en urgence et ostéosynthèse de sa fracture de jambe.
- D. Intubation et ventilation mécanique
- E. Une administration d'acide tranexamique

Cas clinique 10

Une femme âgée de 48 ans, aux antécédents de thyroïdite auto-immune et vitiligo, consulte pour asthénie avec des paresthésies des extrémités. A l'examen, une pâleur cutanéomuqueuse, glossite, Réflexes ostéo-tendineux vifs avec Babinski (+)

NFS : GB=2660 PNN=860 Lym=700 mono 100 Hb= 7.6g/dl VGM=120 PLQ=80000 réticulocytes = 40000

42. L'hémogramme montre:

- A. Une anémie microcytaire arégénérative
- B. Une pancytopénie
- C. Une anémie macrocytaire régénérative
- D. Une lymphopénie
- E. Une thrombocytose

43. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Un myélome multiple
- B. Une anémie ferriprive
- C. Une anémie mégalo-blastique
- D. Une anémie sidéroblastique
- E. Une anémie hémolytique auto-immune

44. Quelle est l'étiologie la plus probable ?

- A. Une anémie de Biermer
- B. Une carence en folates
- C. Une hypertension portale
- D. Un cancer digestif
- E. Un myélome multiple